Epreuve: DFGSM2_2024-2025_UE 6 TSSI_SESSION 1

Element d'épreuve: DP1

Monsieur J, 67 ans, est admis aux urgences après un accident de la voie publique. Alors qu'il était à vélo, il a été renversé par un conducteur qui le doublait de trop près. Il souffre de nombreux traumatismes. Ses membres et son tronc sont le siège de nombreux hématomes. Il a subi un traumatisme crânien, est inconscient et ne répond pas aux questions.Il a une cicatrice de sternotomie semi-récente. Les radiographies montrent des fractures de côtes ainsi que de la clavicule gauche. Vous identifiez également sur le cliché thoracique une valve aortique mécanique. Il y a un minime épanchement pleural gauche.Dans le cadre de sa prise en charge, un bilan hématologique a été réalisé qui retrouve :Hématies : 3,84 T/LHémoglobine : 11,4 g/dL Hématocrite : 34,6% VGM : 90,1 fL TCMH : 29,7 pg CCMH : 32,9% Plaquettes : 251 G/L Leucocytes : 14,4 G/LPolynucléaires Neutrophiles : 12,03 G/LPolynucléaires Eosinophiles : 0,01 G/LPolynucléaires Basophiles : 0,03 G/LLymphocytes : 1,68 G/LMonocytes : 0,64 G/L TP : 37%, TCA 45/32 (ratio à 1,4), Fibrinogène à 3,2 g/L

Question 1: (Type: QRM)

Parmi les éléments suivants, certains sont pertinents pour qualifier la situation de Monsieur J, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Anémie normochrome normocytaire
- [x] B. Anomalie du bilan de coagulation
- [x] C. Allongement isolé du TCA
- [x] D. Probable CIVD sur polytraumatisme
- [x] E. Anomalie de l'hémostase primaire

Question 2: (Type: QRM)

Parmi les propositions suivantes, certaines sont pertinentes pour qualifier la situation de Monsieur J, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Anomalie isolée de la voie intrinsèque
- [x] B. Anomalie isolée de la voie extrinsèque
- [x] C. Probable anomalie de la voie commune
- [x] D. Anomalie de la fibrinolyse
- [x] E. Anomalie isolée de la fibrinoformation

Question 3: (Type: QRM)

Dans cette situation, certains dosages sont pertinents, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Facteur VIII
- [ ] B. Facteur V
- [ ] C. Facteur II
- [ ] D. Facteur X
- [ ] E. Facteur Willebrand

Question 4: (Type: QRM)

Parmi les situations suivantes, certaines sont susceptibles d'allonger le TP, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Diminution isolée du facteur VII
- [ ] B. Diminution isolée du facteur VIII
- [ ] C. Diminution isolée du facteur V
- [ ] D. Diminution isolée de la protéine C
- [x] E. Diminution isolée du facteur II

Question 5: (Type: QRM)

Parmi les situations suivantes, certaines sont susceptibles d'allonger le TP, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Insuffisance hépatique
- [ ] B. Hémophilie A
- [x] C. Carence en vitamine K
- [ ] D. Carence en vitamine B9
- [x] E. CIVD

Question 6: (Type: QRM)

Parmi les situations suivantes, certaines sont susceptibles d'allonger isolément le TCA, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Carence en vitamine K
- [ ] B. Hémophilie B
- [x] C. CIVD
- [ ] D. Insuffisance hépatique
- [ ] E. Carence en vitamine B9

Question 7: (Type: QRM)

Parmi les situations suivantes, certaines sont susceptibles d'allonger le TP et le TCA, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Carence en vitamine K
- [ ] B. Hémophilie B
- [ ] C. CIVD
- [ ] D. Insuffisance hépatique
- [ ] E. Carence en vitamine B9

Question 8: (Type: QRM)

Les dosages complémentaires retrouvent :Facteur II : 45%Facteur V : 98 %Facteur X : 30%Parmi les situations suivantes, certaines peuvent expliquer ce bilan, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Insuffisance hépatique
- [ ] B. CIVD
- [x] C. Carence en vitamine K
- [ ] D. Carence en vitamine B9
- [ ] E. Hémophilie B

Question 9: (Type: QRM)

Les dosages complémentaires retrouvent :Facteur II : 45%Facteur V : 98 %Facteur X : 30%Parmi les situations suivantes, certaines peuvent expliquer ce bilan, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Traitement par anti-vitamines K
- [ ] B. Traitement par héparines de bas poids moléculaire
- [ ] C. Déséquilibre majeur de la flore intestinale après antibiothérapie à large spectre
- [ ] D. Insuffisance pancréatique exocrine avec malabsorption des lipides
- [ ] E. Traumatisme hépatique

Question 10: (Type: QRM)

A propos de la vitamine K, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Elle est détruite par la cuisson des aliments
- [ ] B. Elle est nécessaire à la synthèse de la protéine C
- [x] C. Elle est indispensable à la carboxylation de certains facteurs de coagulation
- [ ] D. Elle est synthétisée par le foie
- [ ] E. Elle est inhibée par l'héparine

Question 11: (Type: QROC)

Quel est selon vous l'explication la plus probable à la perturbation du bilan d'hémostase de monsieur J ?

Element d'épreuve: DP2

L'enfant J, 18 mois, est amené pas ses parents pour gonflement du genou. Alors qu'il commençait à marcher, l'enfant a présenté un gonflement du genou qui semble douloureux. Il pleure beaucoup.A l'examen, il présente des hématomes au niveau des membres supérieurs et inférieurs, de plusieurs cm de diamètre. Les parents indiquent qu'il n'y a pas eu de traumatisme expliquant ces hématomes.La pression artérielle est à 120/65, la fréquence cardiaque à 75/min, la température à 37°2.Le genou gauche est gonflé, peu inflammatoire mais douloureux à la mobilisationIl n'y a pas d'autre particularité à l'examen.

Question 1: (Type: QRM)

Parmi les syndromes suivants, un ou plusieurs peu(ven)t être présent(s) dans cette observation, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. syndrome anémique
- [x] B. syndrome hémorragique
- [x] C. syndrome infectieux
- [x] D. syndrome tumoral
- [x] E. syndrome d'insuffisance médullaire

Question 2: (Type: QROC)

Le tableau clinique présenté par ce jeune garçon évoque l'anomalie d'un processus physiologique précis. Donnez le nom du processus physiologique supposément anormal.

Question 3: (Type: QRM)

Parmi les examens complémentaires suivants, certains sont pertinents en première intention pour l'exploration de ce tableau, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Hémogramme
- [ ] B. Myélogramme
- [ ] C. Détermination du TP
- [ ] D. Détermination du TCA
- [ ] E. Dosage du fibrinogène

Question 4: (Type: QRM)

L'externe de garde aux urgences indique qu'il a déjà reçu un enfant avec de nombreux "bleus" qui ont permis la découverte d'une thrombopénie. Parmi les affirmations suivantes concernant les thrombopénies, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Elle se définissent par un taux de plaquettes inférieur à 150 G/L
- [ ] B. Elles entraînent des anomalies de l'hémostase primaire
- [x] C. Elles sont d'autant plus dangereuses que le chiffre de plaquettes est bas
- [ ] D. Une fausse thrombopénie peut résulter d'une agrégation des plaquettes à l'EDTA
- [x] E. Elles peuvent être liées à une consommation excessive des plaquettes

Question 5: (Type: QRM)

Parmi les signes cliniques suivants, certains sont évocateurs de thrombopénie, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Purpura
- [x] B. Hémarthrose
- [x] C. Ecchymose
- [x] D. Épistaxis récidivante
- [x] E. Ménorragies

Question 6: (Type: QRM)

Pendant que vous devisiez avec l'externe de garde, les résultats des examens biologiques ont été rendus.L'hémogramme retrouve :Hématies : 4,19 T/LHémoglobine : 11,3 g/dl Hématocrite : 33,6% VGM : 80.2 fl TCMH : 27 pg CCMH : 33,6% Plaquettes 315 G/L Leucocytes : 8,1 G/LPolynucléaires Neutrophiles : 3,03 G/LPolynucléaires Eosinophiles : 0,24 G/LPolynucléaires Basophiles : 0,04 G/LLymphocytes : 4,25 G/LMonocytes : 0,52 G/L Le TP est à 97%, le TCA à 59/33 soit un ratio à 1,8, le fibrinogène est à 2,6 g/L.Parmi les propositions suivantes, certaines sont appropriées, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. On retrouve une atteinte de la voie extrinsèque
- [ ] B. On retrouve une anomalie de l'hémostase primaire
- [x] C. On peut confirmer/préciser l'anomalie en réalisant un TCK

[X] D. Le bilan biologique (indépendamment du contexte clinique) serait compatible avec la présence d'un anticoagulant circulant

[X] E. Le bilan biologique est compatible avec une dysfibrinogénémie

Question 7: (Type: QRM)

Pendant que vous devisiez avec l'externe de garde, les résultats des examens biologiques ont été rendus.L'hémogramme retrouve :Hématies : 4,19 T/LHémoglobine : 11,3 g/dl Hématocrite : 33,6% VGM : 80.2 fl TCMH : 27 pg CCMH : 33,6% Plaquettes 315 G/L Leucocytes : 8,1 G/LPolynucléaires Neutrophiles : 3,03 G/LPolynucléaires Eosinophiles : 0,24 G/LPolynucléaires Basophiles : 0,04 G/LLymphocytes : 4,25 G/LMonocytes : 0,52 G/L Le TP est à 97%, le TCA à 59/33 soit un ratio à 1,8, le fibrinogène est à 2,6 g/L.Le TCK est à 60/32 soit un ratio à 1,89Parmi les explorations complémentaires suivantes, certaines sont indispensables, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Dosage du facteur V

[X] B. Dosage du facteur VIII

[X] C. Dosage du facteur IX

[X] D. Dosage du facteur XIII

[X] E. Dosage de la protéine C

Question 8: (Type: QRM)

Pendant que vous devisiez avec l'externe de garde, les résultats des examens biologiques ont été rendus.L'hémogramme retrouve :Hématies : 4,19 T/LHémoglobine : 11,3 g/dl Hématocrite : 33,6% VGM : 80.2 fl TCMH : 27 pg CCMH : 33,6% Plaquettes 315 G/L Leucocytes : 8,1 G/LPolynucléaires Neutrophiles : 3,03 G/LPolynucléaires Eosinophiles : 0,24 G/LPolynucléaires Basophiles : 0,04 G/LLymphocytes : 4,25 G/LMonocytes : 0,52 G/L Le TP est à 97%, le TCA à 59/33 soit un ratio à 1,8, le fibrinogène est à 2,6 g/L.Le TCK est à 60/32 soit un ratio à 1,89Parmi les diagnostics suivants, certains sont compatibles avec le tableau clinico-biologique, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Hémophilie A

[X] B. Hémophilie B

[X] C. CIVD

[X] D. Anticoagulant circulant de type lupique

[X] E. Déficit en facteur XIII

Question 9: (Type: QROC)

Les dosages suivants ont été réalisés :Facteur VIII : 2%Facteur IX : 89%Facteur XI : 79%Facteur XII : 75%Quel diagnostic précis proposez-vous ?

Question 10: (Type: QRM)

Si un diagnostic d'hémophilie est retenu, une ou plusieurs proposition(s) est (sont) pertinente(s), cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Le père de l'enfant est probablement hémophile
- [x] B. La soeur de l'enfant est probablement hémophile
- [x] C. Le frère de l'enfant a une chance sur deux d'être hémophile
- [x] D. Une mutation pourra être retrouvée sur le gène du facteur VIII, à l'état hétérozygote
- [x] E. L'enfant, une fois adulte, ne pourra pas transmettre la maladie à sa descendance

Element d'épreuve: DP3

Monsieur W consulte en raison de douleurs abdominales. Il décrit une sensation de gène sur le côté gauche, constante, non rythmée par les repas, depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas de nausées, pas de vomissements, pas de trouble du transit.La pression artérielle est à 125/65, la fréquence cardiaque à 65/min, la température à 36°9.La palpation abdominale retrouve une masse de l'hypocondre gauche.

Question 1: (Type: QRM)

Parmi les syndromes suivants, certains peuvent être représentés dans l'observation, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Syndrome anémique
- [x] B. Syndrome hémorragique
- [x] C. Syndrome infectieux
- [x] D. Syndrome tumoral
- [x] E. Syndrome d'insuffisance médullaire

Question 2: (Type: QRM)

Parmi les éléments suivants, certains peuvent orienter vers une splénomégalie pour expliquer la masse abdominale. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. La masse est mobile à l'inspiration profonde
- [x] B. La masse est fixée
- [x] C. La masse est molle, dépressible
- [x] D. la masse présente un rebord antérieur tranchant, crénelé
- [x] E. La masse donne un contact lombaire

Question 3: (Type: QRM)

A propos de la splénomégalie, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Elle peut s'accompagner d'hypersplénisme
- [x] B. Elle peut majorer le risque de rupture splénique
- [x] C. Elle peut témoigner d'une hyperhémolyse chronique
- [x] D. Elle peut révéler une hémopathie lymphoïde
- [x] E. Elle est très fréquente dans les myélodysplasies

Question 4: (Type: QRM)

Un hémogramme est réalisé. Il retrouve :Hématies : 5,3 T/LHémoglobine : 15,1 g/dL Hématocrite : 44,2 % VGM : 83,4 fL TCMH : 28.5 pg CCMH : 34,2% IDR : 15,5Plaquettes : 595 G/L VPM : 9,2 fLLeucocytes : 23,1 G/LFormule réalisée au microscope Polynucléaires Neutrophiles : 69.5 % / 16,1 G/L Polynucléaires Eosinophiles : 3,5 % / 0.81 G/L Polynucléaires Basophiles : 2.5% / 0,58 G/L Lymphocytes : 13% / 3,00 G/L Monocytes : 3% / 0,69 G/L Métamyélocytes : 6 % Myélocytes : 4 %Parmi les éléments ci dessous, certains peuvent décrire l'hémogramme, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. hyperleucocytose
- [x] B. myélémie
- [x] C. thrombopénie
- [x] D. macrocytose
- [x] E. hyperéosinophilie

Question 5: (Type: QRM)

A propos des polynucléaires neutrophiles, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Ce sont les cellules les plus nombreuses de la granulopoïèse
- [x] B. Parmi leurs progéniteurs, on trouve les CFU-GM
- [x] C. Ils sont capables de bactéricidie
- [x] D. Ils sont capables de migration tissulaire
- [x] E. Ils vivent en moyenne 7 à 10 jours

Question 6: (Type: QRM)

A propos des (hyper)polynucléoses neutrophiles, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Peuvent être causées par une démargination importante
- [x] B. Peuvent être d'origine ethnique

[X] C. Peuvent être dues à des carences en vitamine B12
[X] D. Peuvent se voir suite à l'ingestion de toxiques ou de certains médicaments
[X] E. Elles majorent le risque infectieux

Question 7: (Type: QRM) [X]

A propos des hyperéosinophilies, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Elles sont définies par un taux de polynucléaires éosinophiles supérieur à 1,5 G/L
[X] B. Elles peuvent témoigner d'une allergie
[X] C. Elles peuvent témoigner d'une expansion de lymphocytes de type Th2
[X] D. Elles peuvent révéler une hémopathie maligne
[X] E. Elles peuvent avoir des conséquences délétères sur les tissus, en particulier cardiaques

Question 8: (Type: QRM) [X]

A propos de la myélémie, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Il s'agit du passage sanguin de cellules souches hématopoïétiques
[X] B. Elle peut être déséquilibrée, témoignant d'une anomalie de maturation
[X] C. Elle ne peut se voir qu'au cours des hémopathies malignes
[X] D. Elle peut comporter la présence de myélocytes
[X] E. Elle ne peut se voir qu'en pratiquant un myélogramme

Question 9: (Type: QRM) [X]

Compte tenu de la présentation clinique et de l'hémogramme, certaines étiologies sont plausibles pour notre patient, cochez la/les réponse(s) exacte(s)Hématies : 5,3 T/LHémoglobine : 15,1 g/dL Hématocrite : 44,2 % VGM : 83,4 fL TCMH : 28,5 pg CCMH : 34,2% IDR : 15,5Plaquettes : 595 G/L VPM : 9,2 fLLeucocytes : 23,1 G/LFormule réalisée au microscope Polynucléaires Neutrophiles : 69,5 % / 16,1 G/L Polynucléaires Eosinophiles : 3,5 % / 0,81 G/L Polynucléaires Basophiles : 2.5% / 0,58 G/L Lymphocytes : 13% / 3,00 G/L Monocytes : 3% / 0,69 G/L Métamyelocytes : 6 % Myélocytes : 4 %

[X] A. Un infection pourrait expliquer une hyperleucocytose avec polynucléose et myélémie
[X] B. Une démargination importante (effort physique) pourrait expliquer l'hémogramme
[X] C. Les anomalies de l'hémogramme pourraient être en rapport avec un hypersplénisme
[X] D. Il pourrait s'agir d'un syndrome myéloprolifératif
[X] E. Il pourrait s'agir d'une leucémie lymphoïde chronique

Question 10: (Type: QROC) [X]

Vous éliminez les causes réactionnelles et retenez une hypothèse d'hémopathie maligne. Quel est le diagnostic le plus probable ?

Question 11: (Type: QRM)

A propos des syndromes myéloprolifératifs, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

A. Ils sont principalement dus à des défauts de différenciation
B. Ils sont le plus souvent dus à des anomalies de tyrosine-kinases
C. Ils entraînent principalement des cytopénies
D. Ils sont le plus souvent révélés par un syndrome d'insuffisance médullaire
E. Il ne s'accompagnent quasiment jamais de syndrome tumoral

Element d'épreuve: DP4

Une femme de 47 ans consulte pour l'apparition progressive depuis quelques mois d'une fatigue, dont l'intensité augmente. Elle a de plus en plus de difficultés à monter les trois étages qui mènent à son appartement, et se sent essoufflée. Elle décrit en outre des sensations inhabituelles de fourmillement au niveau des membres inférieurs, de façon bilatérale.A l'examen, vous trouvez un pâleur conjonctivale, une pression artérielle à 130/70, une fréquence cardiaque à 85/min, une température à 37°2.L'examen abdominal, cardiaque ou pulmonaire est sans particularité. Les aires ganglionnaires sont libres.

Question 1: (Type: QRM)

Parmi les syndromes suivants, un ou plusieurs peu(ven)t être présent(s) dans l'observation présentée, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

A. Syndrome hémorragique
B. Syndrome anémique
C. Syndrome infectieux
D. Syndrome tumoral
E. Syndrome d'insuffisance médullaire

Question 2: (Type: QRM)

Parmi les éléments suivants, un ou plusieurs est/sont évocateur(s) de syndrome anémique (indépendamment de l'étiologie), cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Tachycardie
- [x] B. Bradycardie
- [x] C. Polypnée
- [x] D. Pétéchies
- [x] E. Adénopathie

Question 3: (Type: QRM)

Vous proposez de réaliser un hémogramme. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. L'hémogramme se pratique par ponction sternale
- [x] B. L'hémogramme doit être prélevé sur un tube contenant un anticoagulant, l'EDTA
- [x] C. L'hémogramme permet d'analyser uniquement les lignées myéloïdes
- [x] D. L'hémogramme peut être réalisé en urgence, en moins d'une heure
- [x] E. L'hémogramme permet le plus souvent de confirmer ou d'infirmer une suspicion d'anémie

Question 4: (Type: QRM)

L'hémogramme retrouve :Hématies : 2,77 T/LHémoglobine : 9,2 g/dL Hématocrite : 29,8 % VGM : 106,3 fL TCMH : 33,2 pg CCMH : 31,9% IDR : 20,6Plaquettes : 142 G/L VPM : 12,.2 fLLeucocytes : 7,24 G/L Polynucléaires Neutrophiles : 56,0 % / 4,05 G/L Polynucléaires Eosinophiles : 0,7 % / 0,05 G/L Polynucléaires Basophiles : 0,6 % / 0,04 G/L Lymphocytes : 35,5 % / 2,57 G/L Monocytes : 7,2 % / 0,52 G/L Parmi les éléments suivants, un ou plusieurs s'applique(nt) à la description de l'hémogramme, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Anémie
- [x] B. Macrocytose
- [x] C. Hypochromie
- [x] D. Hyperlymphocytose
- [x] E. Myélémie

Question 5: (Type: QRM)

Concernant la macrocytose, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Elle est définie par un VGM > 80 fL
- [x] B. Elle est définie par une TCMH > 27 pg
- [x] C. Elle peut résulter d'une anomalie des divisions lors de l'érythropoïèse
- [x] D. Elle évoque en priorité une carence martiale
- [x] E. Il peut s'agir d'un signe de myélodysplasie

Question 6: (Type: QRM)

Face à une anémie macrocytaire, certaines explorations sont pertinentes, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Dosage de réticulocytes
- [ ] B. Dosage de la vitamine B12
- [ ] C. Dosage de la transferrine
- [ ] D. Dosage de la vitamine K
- [ ] E. Dosage de la vitamine B9

Question 7: (Type: QRM)

Compte tenu du chiffre d'hémoglobine, le biologiste a ajouté au bilan prescrit un dosage de réticulocytes. Il retrouve 35 G/L. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. L'anémie est arégénérative
- [x] B. On doit suspecter une hémolyse
- [ ] C. Les réticulocytes sont des globules rouges nucléés
- [ ] D. Une réticulocytose très élevée pourrait expliquer une macrocytose modérée
- [ ] E. Ce dosage était inutile car les anémies macrocytaires sont toujours arégénératives

Question 8: (Type: QRM)

Face à ce tableau, vous proposez la réalisation d'un myélogramme. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Ce geste est contre indiqué en cas de thrombopénie
- [x] B. Il est le plus souvent réalisé par ponction sternale
- [ ] C. Cet examen permettra de s'assurer de l'absence de fibrose médullaire
- [ ] D. Cet examen permettra de confirmer ou d'infirmer une dysplasie érythroblastique
- [ ] E. Cet examen nécessitera une anesthésie générale

Question 9: (Type: QRM)

Le myélogramme retrouve une moelle riche avec une érythropoïèse active, présentant de nombreux érythroblastes basophiles de grande taille, ainsi qu'un gigantisme cellulaire sur la lignée granuleuse. Vous recevez également les résultats du dosage de vitamine B9, qui est normal et B12, qui est très diminué. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

- [x] A. Une mégaloblastose est typique des carences en vitamines B9 ou B12
- [ ] B. Les anomalies du myélogramme suggèrent une leucémie aiguë
- [ ] C. La mégaloblastose s'explique par le rôle des B9 et B12 dans la synthèse de l'ADN

[X] D. La carence en vitamine B12 explique les signes neurologiques décrits

[X] E. L'avortement intramédullaire explique la discordance entre la richesse de la moelle et le taux de réticulocytes

Question 10: (Type: QRM) [X]

A propos des vitamines B12, cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Ce sont des cobalamines, comportant un atome de cobalt

[X] B. Elles sont apportées par les légumes frais

[X] C. Elles sont absorbées dans l'estomac

[X] D. Elles sont absorbées au niveau iléal

[X] E. Elles sont stockées par le foie

Question 11: (Type: QRM) [X]

Il est proposé pour cette patiente un diagnostic de maladie de Biermer. Cochez la/les réponse(s) exacte(s)

[X] A. Cette maladie entraîne aussi une carence en folates

[X] B. Cette maladie comporte une gastrite auto-immune

[X] C. Cette maladie entraîne un défaut de facteur intrinsèque

[X] D. Cette maladie peut entraîner un subictère en raison de l'avortement érythroblastique intramédullaire

[X] E. Cette maladie peut entraîner des signes neurologiques

Element d'épreuve: SQI1 [X]

Question 1: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant le conduit thoracique : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. De façon modale, le conduit thoracique se jette directement dans la veine jugulaire postérieure gauche

[X] B. Il existe des variations de naissance du conduit thoracique

[X] C. De façon modale, le conduit thoracique se termine à l’étage abdominal

[X] D. Le système lymphatique thoraco-abdominal n’assure que le drainage des lymphocentres viscéraux

[X] E. Aucune proposition n’est exacte

Question 2: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant les lymphonoeuds : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Le drainage lymphatique testiculaire se réalise principalement via les lymphonoeuds inguinaux

[X] B. Le drainage lymphatique des glandes mammaires se réalise notamment via les lymphonoeuds épigastriques inférieurs

[X] C. En échographie, les lymphonoeuds ont normalement une différenciation cortico-médullaire visible

[X] D. La vascularisation normale des lymphonoeuds provient de la périphérie

[X] E. Aucune proposition n’est exacte

Question 3: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant un lymphocyte T : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Se reconnaît à l'expression de la molécule CD19

[X] B. Se reconnaît à l'expression de la molécule CD20

[X] C. Reconnaît un antigène grâce à son TCR

[X] D. Est impliqué dans la réponse immunitaire adaptative

[X] E. Peut participer à la réponse immunitaire innée

Question 4: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant les cellules présentatrices d'antigènes : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Elles captent l'antigène pour le présenter aux lymphocytes B par les molécules HLA II

[X] B. Elles captent l'antigène pour le présenter au lymphocyte T CD8 par les molécules HLA I

[X] C. Elles appartiennent à la lignée des monocytes-macrophages

[X] D. Elles sont des cellules cytotoxiques très efficaces

[X] E. Elles expriment des molécules CD4 après activation

Question 5: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant les organes lymphoïdes secondaires : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Le premier à être utilisé après la naissance est la moelle osseuse

[X] B. Ils se développent tout au long de la vie même sans stimulation antigénique

[X] C. Ils sont le siège de l’acquisition de fonctions par les lymphocytes T et B

[X] D. La prolifération cellulaire s’y observe uniquement sous stimulation antigénique

[X] E. Aucune proposition n’est exacte

Question 6: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant une réponse immunitaire cellulaire : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Elle met en jeu les cellules de la lignée monocytaire
B. Elle met en jeu les cellules Th1
C. Elle se déclenche rapidement après introduction d'un antigène dans l'organisme
D. Elle se caractérise par la sécrétion de cytokines de type 1 (ex : IL-2, IFN-gamma)
E. Aucune proposition n'est exacte

Question 7: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant l'immunité innée : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. L'immunité innée met en place une réaction immunitaire rapide, locale et systémique
B. L'immunité innée est bien plus efficace lors de la seconde introduction du même agent
C. L'immunité innée permet la mise en place de la réaction inflammatoire
D. L'immunité innée met en jeu des cellules et des molécules solubles
E. Aucune proposition n'est exacte

Question 8: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant les premières lignes de défense contre les infections microbiennes : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Ce sont les barrières tissulaires physiques et mécaniques
[X] B. Ce sont les cellules phagocytaires (polynucléaires, macrophages et cellules dendritiques)
[X] C. Ce sont les molécules solubles antimicrobiennes comme le lysozyme
[X] D. C'est le système du complément
E. Ce sont les lymphocytes T

Question 9: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant la phagocytose : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

[X] A. Elle permet d'éliminer les agents infectieux
[X] B. Elle nécessite une reconnaissance spécifique des molécules infectieuses au travers de PRRs
C. Elle a lieu principalement dans les organes lymphoïdes secondaires
[X] D. Elle permet la présentation des antigènes aux lymphocytes T CD4, T CD8 et aux lymphocytes B
E. Aucune proposition n'est exacte

Question 10: (Type: QRM) [X]

Parmi les propositions suivantes, concernant la réaction inflammatoire : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

- [x] A. La réaction inflammatoire est initiée par les cellules immunitaires au site d'introduction des pathogènes
- [x] B. La réaction inflammatoire permet l'élimination des bactéries
- [x] C. La réaction inflammatoire est physiologiquement toujours locale
- [x] D. La réaction inflammatoire est indispensable à l'initiation de la réponse immunitaire
- [x] E. La réaction inflammatoire permet la cicatrisation des tissus

Question 11: (Type: QRM)

Parmi les propositions suivantes, concernant l'opsonisation : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

- [x] A. L'opsonisation peut faire intervenir les récepteurs du complément
- [x] B. L'opsonisation peut faire intervenir des PRRs d'endocytose
- [x] C. L'opsonisation peut faire intervenir des récepteurs aux Fragment Fc des anticorps
- [x] D. L'opsonisation est indispensable à la phagocytose
- [x] E. Aucune proposition n'est exacte

Question 12: (Type: QRM)

Parmi les propositions suivantes, concernant le système du complément : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

- [x] A. Les récepteurs du système du complément ne sont exprimés que sur les cellules de l'immunité innée
- [x] B. Les récepteurs du système du complément ont un rôle dans l'immunité adaptative
- [x] C. L'activation des voies classique et alterne aboutissent toutes les deux à la formation d'une C3 convertase
- [x] D. Certaines protéines clivées du complément participent au chimiotactisme
- [x] E. Aucune proposition n'est exacte

Question 13: (Type: QRM)

Parmi les propositions suivantes, concernant les molécules HLA de classe I et de classe II : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

- [x] A. Les molécules HLA de classe I sont exprimées uniquement par les cellules immunitaires
- [x] B. Les molécules HLA de classe II sont exprimées par toutes les cellules nucléées
- [x] C. Les molécules HLA-A, HLA-B et HLA-C sont des HLA de classe I
- [x] D. Les deux classes de molécules HLA présentent toutes les deux des peptides aux lymphocytes T CD4 et T CD8

☒ E. Aucune proposition n'est exacte

Question 14: (Type: QRM) ☒

Parmi les propositions suivantes, concernant l'impact du système HLA en contexte pathologique : la ou lesquelles est ou sont vraie(s) ?

☒ A. La présence du HLA-B27 chez un individu augmente son risque de développer une spondylarthrite ankylosante

B. Le rejet de greffe peut être dû à des lymphocytes T reconnaissant des HLA différents exprimés par le greffon

C. Une compatibilité HLA parfaite est indispensable pour tous les types de greffes

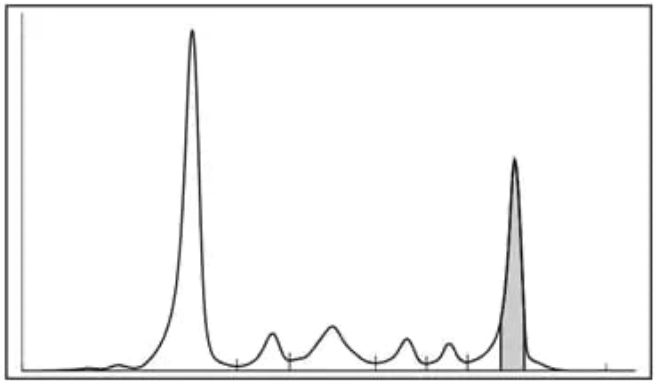
D. Le traitement immunosuppresseur post-greffe permet d'atténuer les effets de la GVH

E. Aucune proposition n'est exacte

Question 15: (Type: QRM) ☒

Concernant le profil électrophorétique des protéines sériques, interpréter le graphe suivant :

Examens			Résultats	Unités	Valeurs de référence
BIOCHIMIE - SANG					
Electrophorèse des protéines					
Electrophorèse capillaire (Capillarys 3 Tera / Phoresis - SEBIA)					
Protéines sériques *Spectrophotométrie Biuret (Atellica Siemens)*			76.2	g/L	57.0-82.0
Albumine	47.8	% soit	**36.4**	**g/L**	40.2-47.6
Alpha-1 globulines	5.8	% soit	**4.4**	**g/L**	2.1-3.5
Alpha-2 globulines	11.8	% soit	**9.0**	**g/L**	5.1-8.5
Bêta-1 globulines	5.1	% soit	**3.9**	**g/L**	3.4-5.2
Bêta-2 globulines	3.8	% soit	**2.9**	**g/L**	2.3-4.7
Gamma globulines	25.7	% soit	**19.6**	**g/L**	8-13.5
Rapport Albumine/Globulines			0.92		
Pic 1	20.0	% soit	**15.2**	**g/L**	



☒ A. Ce profil fait évoquer un syndrome inflammatoire

[X] B. On retrouve une hypergammaglobulinémie d’allure monoclonale

C. Une hémopathie maligne doit être recherchée

D. Cet aspect doit faire réaliser une immunosoustraction ou une immunofixation

E. Aucune proposition n’est exacte